

Briefing de Figuras — Capítulo 11

“Seu Placar de Longevidade: Onde Você Está?”

DIRETRIZES GERAIS

Manter paleta e tipografia consistentes com os briefings anteriores:

- Verde escuro (#2D6A4F): zona ótima / segura
- Amarelo-âmbar (#E9C46A): zona de alerta / subótima
- Vermelho suave (#E76F51): zona de risco / alto risco
- Cinza médio (#8D99AE): referência / comparação
- Azul escuro / grafite (#264653): dados do paciente / destaque principal
- Fundo: branco ou off-white (#FAFAFA)
- Tipografia: sans-serif limpa (Inter, Source Sans Pro ou similar). Títulos 14–16pt bold, rótulos 10–12pt regular.
- Formato: vetor (SVG ou AI) + PNG alta resolução (300 dpi, mínimo 2000px largura).

Nota sobre o capítulo: o Cap 11 é um capítulo narrativo de síntese, não um capítulo com conceitos clínicos novos. As duas figuras existem para resolver problemas concretos de leitura — um parágrafo denso em números que fica difícil de acompanhar sem imagem (Marcos, Regra dos Dois) e uma lista cumulativa de exames por década que fica mais útil como referência visual do que como prosa corrida. Não há figura para “o placar” como instrumento visual — o placar é conceito narrativo do capítulo, não produto a ser embalado.

FIGURA 1 — Trajetória de Marcos: Painel Antes e Depois de Oito Meses

Objetivo comunicacional

O parágrafo da Regra dos Dois que descreve o caso Marcos contém onze números em

sequência (ApoB 82→58, insulina 11→6, PCR 1,6→0,6, vitamina D 28→52, +1,8 MET, –5 kg gordura, +2 kg massa magra, CAC 412 inalterado). Nenhum leitor retém tudo isso em prosa corrida. A figura traduz esse parágrafo em imagem, usando a mesma linguagem visual dos dot plots horizontais que o leitor já viu nos Capítulos 7, 8, 9 e 10 — continuidade visual, sem reaprender formato.

A figura também comunica visualmente a mensagem central da seção: a maioria dos marcadores mudou de zona; um marcador (CAC) não mudou e nunca vai mudar — e isso faz parte do plano, não é falha.

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: *“O CAC de 412 não mudou — cálcio depositado não se dissolve. O que mudou foi a velocidade do processo daqui em diante.”*

Tipo de gráfico

Dot plot horizontal pareado — formato idêntico ao das figuras de follow-up dos Capítulos 7 (Marcos, pilar A), 8 (Paulo, pilar G), 9 (Ana, pilar I) e 10 (Paulo, pilar R). Eixo Y com os marcadores listados de cima para baixo; eixo X com a escala normalizada por faixa de referência; dois pontos por linha (baseline e 8 meses) conectados por segmento horizontal que mostra direção e magnitude da mudança.

A diferença em relação às figuras anteriores é que esta é a **figura de síntese** — reúne marcadores de mais de um pilar (A e G) num único painel, mostrando o efeito conjunto das duas frentes da Regra dos Dois.

Estrutura visual

Eixo Y (vertical, de cima para baixo) — sete marcadores:

1. ApoB (mg/dL)
2. Insulina de jejum (μ IU/mL)
3. PCR ultrasensível (mg/L)
4. Vitamina D (ng/mL)
5. Ergometria (variação em MET)
6. Composição corporal (variação em kg)
7. CAC (Agatston score)

Eixo X (horizontal): faixa contínua com três zonas de fundo pintadas em transparência

baixa (~10%):

- Verde (#2D6A4F, 10%): zona ótima
- Âmbar (#E9C46A, 10%): zona de alerta
- Vermelho (#E76F51, 10%): zona de risco

As fronteiras entre zonas correspondem aos pontos de corte do livro (ApoB: ótimo <60, alerta 60–90, risco >90; insulina: ótimo <8, alerta 8–12, risco >12; PCR: ótimo <1,0, alerta 1,0–2,0, risco >2,0; vitamina D: ótimo 40–60, alerta 20–40, risco <20).

Pontos e segmentos:

- Ponto do baseline (mês 0): círculo preenchido em **vermelho suave (#E76F51)** ou **âmbar (#E9C46A)**, conforme a zona em que o valor caía
- Ponto do follow-up (mês 8): círculo preenchido em **verde escuro (#2D6A4F)** para todos os marcadores que entraram na zona ótima
- Segmento conectando os dois pontos: linha fina em **azul escuro (#264653)**, com seta discreta apontando para o ponto de destino
- Para os marcadores 5 e 6 (ergometria e composição), que são variações e não valores absolutos: apenas o ponto de follow-up, com rótulo “+1,8 MET” e “–5 kg gordura / +2 kg massa magra”

Tratamento especial do item 7 (CAC 412):

- Único marcador com **dois pontos idênticos** — baseline e follow-up no mesmo lugar (412 = 412)
- Segmento horizontal de comprimento zero; os dois pontos se sobrepõem
- Cor do ponto: **cinza médio (#8D99AE)**, não verde nem vermelho — comunica que não é zona ótima mas também não é falha de tratamento
- Anotação lateral em texto pequeno, em cinza escuro: *“cálcio depositado não regride — trajetória estabilizada”*

Rótulos e anotações

- Cada linha do eixo Y traz o nome do marcador e, entre parênteses, os dois valores: *“ApoB — 82 → 58 mg/dL”*
- Acima do gráfico, à esquerda: *“Marcos, 57 anos — baseline (Cap. 5)”*
- Acima do gráfico, à direita: *“8 meses depois (Cap. 7)”*

- Abaixo do gráfico, nota única centralizada: *“Duas frentes: intensificação farmacológica do ApoB + reestruturação dos três motores do pilar A. Oito meses de ação concentrada.”*

Título e legenda

Título: *“Figura 1. Trajetória de Marcos — painel de biomarcadores antes e oito meses depois da intervenção concentrada em duas frentes.”*

Legenda: *“Dot plot horizontal pareado mostrando sete marcadores-chave do painel de Marcos. Cada par de pontos representa o valor no baseline (círculo em vermelho ou âmbar) e aos oito meses (círculo em verde ou cinza). O CAC de 412, único marcador irreversível, permanece inalterado — o objetivo não é regredir a placa existente, mas estabilizar a trajetória modificando os marcadores ativos. Faixas de referência derivadas dos Capítulos 4 e 7.”*

O que NÃO fazer

- Não incluir marcadores que não foram mencionados no parágrafo do Cap 11 (homocisteína, HOMA-IR) — a figura ilustra exatamente o que o texto descreve, nada mais
- Não usar gráfico de barras — o dot plot horizontal é a linguagem visual já estabelecida no livro
- Não adicionar um terceiro ponto temporal projetado (“aos 12 meses esperaríamos...”) — sai do que o texto afirma
- Não usar ícone ou avatar para representar Marcos
- Não separar os marcadores em “Pilar A” e “Pilar G” com divisórias visuais — a mensagem da Regra dos Dois é justamente que as duas frentes atuaram como plano integrado, não como compartimentos
- Não adicionar logo, marca ou nome de método na figura

FIGURA 2 — Rastreamento por Década: O Que Se Acumula a Cada Janela

Objetivo comunicacional

A seção “Calibração por Década” lista exames e rastreamentos para três janelas etárias (40s, 50s, 60+), com a lógica explícita de que os itens se acumulam — cada década

acrescenta, não substitui. Em prosa corrida, essa informação fica difícil de consultar depois. O leitor que quer saber “o que eu preciso garantir agora, aos 53 anos?” precisa reler três parágrafos densos. A figura resolve isso: é referência visual para consulta rápida, organizada por acúmulo temporal.

Posição no capítulo

Inserir **ao final da seção “Calibração por Década”**, imediatamente antes do separador --
– que abre “Os Sinais Que Não Esperam”.

Tipo de gráfico

Linha do tempo horizontal com três faixas etárias contíguas, cada uma com lista de exames organizados verticalmente. Os exames das décadas anteriores permanecem visíveis (em tom atenuado) nas décadas seguintes, comunicando acúmulo.

Estrutura visual

Layout geral: retângulo apaisado, dividido em três colunas de largura igual por linhas verticais finas em cinza claro. As três colunas são contíguas, sem espaço entre elas — comunicando continuidade.

Cabeçalho de cada coluna:

Coluna esquerda	Coluna central	Coluna direita
40 a 49 anos	50 a 59 anos	60 anos em diante
<i>Detecção precoce</i>	<i>Ação máxima</i>	<i>Preservação funcional</i>

Texto do cabeçalho em azul escuro (#264653). Subtítulo em itálico cinza escuro.

Tom de fundo de cada coluna: suave, diferenciado mas discreto.

- 40s: verde pálido (#EDF5EE)
- 50s: âmbar pálido (#FDF6E8)
- 60+: cinza-azulado pálido (#EEF0F4)

Conteúdo de cada coluna — exames listados verticalmente:

Coluna 40s (itens novos, texto em azul escuro #264653, peso regular):

- Painel ampliado anual (ApoB, PCR-us, HbA1c, insulina jejum, perfil hormonal, TSH/T3/T4, cortisol, IGF-1, vitamina D, B12, ferritina, homocisteína)

- Lp(a) — uma vez na vida
- MTHFR, APOE — uma vez na vida
- Composição corporal (bioimpedância ou DEXA)
- Função renal: creatinina C + microalbuminúria
- CAC score (40–45 anos se risco intermediário ou história familiar)
- Colonoscopia a partir dos 45
- Mamografia anual a partir dos 40 (mulheres)
- Avaliação de saúde mental baseline

Coluna 50s:

- *Todos os itens da coluna 40s permanecem listados, mas em texto cinza médio (#8D99AE) para sinalizar que continuam aplicáveis*
- Itens novos em azul escuro (#264653):
 - CAC score (se ainda não feito)
 - Densitometria óssea (M pós-menopausa; H com indicação)
 - TC tórax baixa dose (50–80a, ≥20 maços-ano, fumante ou parou há ≤15a)
 - Painel hormonal com atenção a menopausa (M) e queda de testosterona (H)
 - Avaliação cognitiva baseline
 - Fundoscopia 1–2 anos
 - USG transvaginal (conforme orientação ginecológica)

Coluna 60+:

- *Todos os itens das colunas 40s e 50s permanecem, em cinza médio*
- Itens novos em azul escuro:
 - Avaliação funcional: sentar/levantar, velocidade de marcha, força preensão palmar
 - ASMI como prioridade na composição corporal
 - Densitometria óssea regular (1–2 anos)
 - Reavaliação cognitiva periódica
 - Rastreamento de audição e visão

- Avaliação de risco de quedas + revisão de medicações sedativas/hipotensoras

Pacientes-âncora (opcional, discreto):

Na parte inferior de cada coluna, uma linha de texto pequeno em cinza escuro com o caso do livro que exemplifica aquela janela:

- 40s: *“Fernanda (Cap. 6) — reverteu todos os marcadores em 6 meses, sem farmacologia”*
- 50s: *“Marcos (Cap. 5/7) — CAC 412 mudou toda a estratégia; Regra dos Dois aplicada”*
- 60+: sem caso específico — nota: *“A década que o leitor prepara quando começa cedo”*

Código de cores

- Exames novos de cada década: azul escuro (#264653)
- Exames acumulados de décadas anteriores: cinza médio (#8D99AE) — este contraste é a mensagem principal da figura: itens não somem, acumulam
- Cabeçalhos: azul escuro, subtítulo em itálico cinza escuro
- Tons de fundo: pálidos como descrito
- Linhas divisórias: cinza claro, finas (1px)

Título e legenda

Título: *“Figura 2. Rastreamento por década — exames e avaliações que se acumulam a cada janela etária.”*

Legenda: *“Cada década acrescenta exames e avaliações à lista anterior, sem substituí-los. Itens em azul escuro são novos para a faixa etária correspondente; itens em cinza são herdados das décadas anteriores e permanecem aplicáveis. A ênfase muda — de detecção precoce nos 40, para ação máxima nos 50, para preservação funcional a partir dos 60 — mas a base se mantém e se expande.”*

O que NÃO fazer

- Não usar três círculos separados ou três setas — sugeriria compartimentos isolados em vez de acúmulo
- Não usar gradientes coloridos intensos que dificultem leitura do texto
- Não transformar em infográfico com ícones de órgãos (coração, cérebro, osso) ao lado de cada exame — ruído visual

- Não adicionar coluna “30s” ou “70+” — o livro trabalha com três janelas; respeitar o escopo
- Não incluir custos, nomes de laboratórios, ou referências a convênios
- Não adicionar logo, marca, nome de método ou nome de clínica

RESUMO

#	Figura	Onde entra	O que resolve
1	Trajetória de Marcos (dot plot antes/depois)	Após caso Marcos na Regra dos Dois	Parágrafo com 11 números que o leitor não retém em prosa — a figura mostra a mudança de trajetória em imagem, na linguagem visual já estabelecida pelo livro
2	Rastreamento por década (linha do tempo cumulativa)	Final da seção Calibração por Década	Três parágrafos densos de exames por faixa etária — a figura organiza em referência visual consultável, mostrando que itens acumulam em vez de substituir

Total: **duas figuras**. Um capítulo narrativo de síntese não precisa de mais. Nenhuma delas embala um produto ou batiza uma ferramenta — ambas resolvem problemas concretos de leitura.